报告类别：B

香港大学深圳医院

The University of Hong Kong - Shenzhen Hospital

健康评估报告

Health Assessment Report

条码：*1909120228*

流 水 号：1909120228

病 人 号：AK7114603

姓　　名：李奎声

性　　别：男

年　　龄：25

联系电话：17615847176

部　　门：集团财经

体 检 告 知 书

尊敬的　　李奎声　　先生：

感谢你对香港大学深圳医院体检中心的信任，我们将本着认真负责的态度，为你的健康做出评估，力争做到疾病早发现、早诊断。但是由于目前医学技术的限制和人体差异，部分异常情况及疾病难以通过一次常规体检得以明确诊断，有些疾病还需要通过多种方法的检测才得以发现，有些还需要复查，或进一步转专科检查。正常的体检结果并不代表身体一定没有疾病，任何一次医学检查都不具备绝对的特异性和灵敏度，一旦出现身体的任何不适情况，建议你及时到医生那里咨询就诊。

香港大学深圳医院特此温馨告知！

香港大学深圳医院
体检中心

检查结果汇总

尊敬的阁下您好，您本次检查的结果汇总如下：

▲　体检评估

ESS评估评分：7 ；运动情况：运动少

视力情况判断：矫正视力下降

▲　体格检查

咽炎

▲　检验科（生化）

直接胆红素(Dbil):4.46 ↑

血葡萄糖(GLU):3.94 ↓

尿酸(UA):451.37 ↑

▲　超声科

轻度脂肪肝。

甲状腺小囊肿。

主检医生建议

尊敬的阁下您好，您本次体检的建议信息如下：

1、[**运动少**]

根据世界卫生组织的建议，成人每周应进行不少于150分钟的有氧运动（如快走），以及不少于两次的全身肌肉锻炼。需要减肥的人士，运动量应在此基础上增加。更多的运动能为健康带来更多好处，但也要量力而行，注意锻炼方式，循序渐进，以避免运动损伤。

2、[**矫正视力下降**]

建议您预约眼科门诊就诊。

3、[**咽炎**]

非感染性咽炎可能是季节性或环境性反应，吸烟者或暴露于二手烟者尤为常见。急性咽炎主要是细菌、病毒或支原体感染，可能会伴有发烧、扁桃体渗出物、颈淋巴结炎、咳嗽或鼻溢。建议戒烟，平时多饮水、清淡饮食，规律作息，加强锻炼。如有明显咽部不适症状，建议预约耳鼻喉专科门诊就诊。

4、[**血糖低**]

最大可能是空腹采血引起，建议您2周后预约荔枝苑慢病综合门诊复查空腹血糖（只需8小时空腹）。

5、[**尿酸偏高**]

血尿酸偏高(＜480 umol/L)可能会引起痛风、肾结石，同时与心脑血管疾病发病增加有关。建议您避免进食动物内脏及饮酒，少吃红肉（猪肉、牛肉）和海鲜，以及低脂肪饮食，多吃高纤维食物及水果蔬菜，每年复查血尿酸。另外，控制体重对降低尿酸也非常重要。

6、[**直接胆红素轻度升高**]

空腹抽血有时会出现胆红素升高，这种升高通常不会对健康造成影响。建议您3-6个月内抽血复查（餐后），同时筛查胆红素升高的原因。

7、[**脂肪肝**]

脂肪肝与肥胖、饮食、喝酒有关，长期脂肪肝会导致肝硬化。建议您低脂饮食、戒酒、加强运动、控制体重，每年复查腹部B超。

8、[**甲状腺囊肿**]

甲状腺囊肿十分常见，通过B超检查可在20-76%的人群中发现结节，其中只有很少数是癌症。您的主检医生经过综合考虑后，建议您3-6个月内预约荔枝苑慢病综合门诊复查甲状腺B超及甲状腺功能检查。

总检医生：　魏晓琴

总检日期：　2019年09月16日

审核医生：　蒋玉杰

审核日期：　2019年09月23日

健康评估

评估者：肖珊				评估日期：2019-09-12			
项目名称	结果	单位	参考值	提示	备注		
PHQ-2	0	/	<3				
ESS	7	/	≤6	↑			
IPSS	/	/	≤7		中度症状：8-19 重度症状：20-35		
尿失禁评估							
AMT	/	/	≥8		认知能力一般：4-7 认知能力差：0-3		
体温	36.5	℃	36.3-37.2				
身高	174.0	厘米 cm	/				
体重	72.0	公斤 kg	/				
体重指数(BMI)	23.78	kg/m 2	18.5-23.9		超重：24-27.9 肥胖：≥28		
腰围	89	厘米 cm	男<90 女<80				
	首测	单位	参考值	复测1	复测2	复测3	
血压 收缩压	132	mmHg	90-139	/	/	/	
血压 舒张压	67	mmHg	60-89	/	/	/	
脉搏	70	次/分	60-100	/	/	/	
	首测发现血压异常 ☐						
裸眼视力 右		/	≥0.8				
裸眼视力 左		/					
矫正/小孔视力 右	0.8	/	≥0.8				
矫正/小孔视力 左	0.6	/		↓			
色觉	正常	/	/		首次发现色觉异常	☐	
听力 右		/	/				
听力 左		/					

药物过敏： ● 无　○ 有（请注明药名）

PHQ-2调查：　评分：　0　分

在最近两周，你是否受到以下问题的困扰？

（请用"√"选出您的答案）	从来没有	有几天	超过一半天数	接近每天
1. 做任何事都觉得沉闷或者根本不想做任何事	●	○	○	○
2. 情绪低落，抑郁或是绝望	●	○	○	○

以下表中带*号的资料由客户本人在系统中确认，港大医院对表中资料的真实性，恕不承担任何责任。

个人史(*)							
常见的状况		**有**	**确诊年龄**	**常见的状况**		**有**	**确诊年龄**
血压异常	高血压病	/	岁	甲状腺疾病	结节	/	岁
	血压升高	/	岁			/	岁
血糖异常	糖尿病	/	岁	乙肝、丙肝或病毒携带		/	岁
	血糖升高	/	岁			/	岁
冠心病		/	岁	贫血		/	岁
高血脂症		/	岁	骨折(请注明患处)		/	岁
癌症(请注明患处)		/	岁	外科手术		/	岁
		/	岁			/	岁
		/	岁			/	岁
结核病(请注明患处)		/	岁	其他		/	岁
		/	岁	其他		/	岁
			岁	其他		/	岁
				其他		/	岁

个人当前服用的药物 (*)	/	/	/

家族史 (*)	高血压病	关系	父亲	确诊年龄	45　岁

生活模式(*)：

运动	☐ 经常：每周 ____ 分钟	☑ 偶尔，少于一周一次	☐ 没有/甚少
吸烟	☑ 从不	☐ 现有，每天 ____ 支；已吸烟 ____ 年	☐ 从前有，已戒烟 ____ 年
	☐ 偶尔（1周小于7支）		
饮酒	☐ 从不	☑ 偶尔（少于1周1次）	☐ 从前有，已戒酒 ____ 年
	☐ 现有（每周 ____ 次）		

嗜睡量表（ESS）(*)　　评分： 7 **分**

最近1个月时间内，请选择以下情况：

情　况	从不打瞌睡	轻度可能打瞌睡	中度可能打瞌睡	很可能打瞌睡
坐着阅览书刊	○ 0	● 1	○ 2	○ 3
看电视	○ 0	● 1	○ 2	○ 3
在公共场合坐着不动（例如在剧场或开会）	● 0	○ 1	○ 2	○ 3
作为乘客在汽车中坐1小时，中间不休息	○ 0	● 1	○ 2	○ 3
在环境许可时，下午躺下休息	○ 0	○ 1	○ 2	● 3
坐下与人谈话	● 0	○ 1	○ 2	○ 3
午餐不喝酒，餐后安静地坐着	○ 0	● 1	○ 2	○ 3
遇堵车时停车数分钟	● 0	○ 1	○ 2	○ 3

体格检查报告

体格检查(新)　　检查者：魏晓琴/陈浩伟（全科）　　检查日期：2019-09-12

项目名称	检查结果
浅表淋巴结	未见异常
甲状腺	未见异常
乳腺	未见异常
心律	律齐
心率	70
杂音	未闻及
肺部听诊	未见异常
腹部	未见异常
肛诊	弃检
皮肤检查	未见异常
四肢关节	未见异常
外耳	未见异常
外耳道	未见异常
鼓膜	未见异常
鼻腔	未见异常
唇	未见异常
舌	未见异常
涎腺	未见异常
口腔粘膜	未见异常
口咽部	充血
扁桃体	未见异常
牙齿	未见异常
牙周	未见异常
眼科检查（外眼）	未见异常
眼底检查（直接眼底镜法）	未见异常
口腔其它检查	未见异常

实验室检查

血常规　检验者：刘霞　审核者：钟灵　报告时间：2019-09-12

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
白细胞总数(WBC)	6.58		3.89-9.93	10^9/L
红细胞(RBC)	5.02		4.46-5.71	10^12/L
血红蛋白浓度(HGb)	150		133-171	g/L
红细胞压积(HCT)	43.9		39.5-48.8	%
平均红细胞体积(MCV)	87.5		82.0-95.5	fL
平均红细胞血红蛋白含量(MCH)	29.9		27.0-32.4	pg
是否已复片(Film Review)	仅采用仪器计数			
嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)	0.04		0.01-0.07	10^9/L
嗜酸性粒细胞百分比(EOS%)	1.8		1.0-6.0	%
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.6		0.0-1.0	%
中性粒细胞绝对值(NEUT#)	3.39		2.01-7.42	10^9/L
淋巴细胞绝对值(LYM#)	2.54		1.06-3.61	10^9/L
单核细胞绝对值(MON#)	0.48		0.18-0.65	10^9/L
嗜酸性粒细胞绝对值(EOS#)	0.12		0.02-0.45	10^9/L
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)	342		326-357	g/L
红细胞分布宽度-变异系数(RDW-CV)	12.4		11.2-13.9	%
血小板总数(PLT)	233		162-341	10^9/L
中性粒细胞百分比(NEUT%)	51.5		44.0-72.0	%
淋巴细胞百分比(LYM%)	38.6		20.0-45.0	%
单核细胞百分比(MON%)	7.3		2.0-10.0	%

肝功能七项　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
谷丙转氨酶(ALT)	48.63		0.00-50.00	U/L
总胆红素(TBIL)	19.82		5-21	umol/L
直接胆红素(Dbil)	4.46	↑	0.00-3.40	umol/L
γ-谷氨酰转肽酶(GGT)	33.75		0-55	U/L
谷草转氨酶(AST)	30.43		0-50	U/L
碱性磷酸酶(ALP)	69.16		30-120	U/L
白蛋白(ALB)	47.82		35.00-52.00	g/L

血脂四项　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
甘油三酯(TG)	0.62		请看注释	mmol/L

实验室检查

血脂四项　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
胆固醇(CHOL)	3.53		请看注释	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	2.36		请看注释	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	1.00		请看注释	mmol/L
注:甘油三酯(Trig)	正常水平<1.70mmol/L 临界性高水平1.70-2.25mmol/L 高水平2.26-5.64mmol/L 很高水平≥5.65mmol/L			
注:胆固醇(CHOL)	符合需要水平<5.2mmol/L 临界性高水平5.2-6.2mmol/L 高水平≥6.2mmol/L			
注:低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	最佳:<2.6mmol/L 接近最佳:2.6-3.3mmol/L 临界高值:3.4-4.1mmol/L 高值:4.2-4.9mmol/L 非常高值:≥4.9mmol/L			
注:高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	低值:< 1.03mmol/L （冠状心血管疾病主要危险因素） 高值:≥1.55mmol/L （冠状心血管疾病"负"危险因素）			

空腹血糖　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
血葡萄糖(GLU)	3.94	↓	4.1-5.9	mmol/L

甲胎蛋白(AFP)　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
甲胎蛋白(AFP)	1.88		0.0-9.0	ng/ml

CA199　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
糖类抗原CA199(CA199)	3.7		0-35	U/ml

癌胚抗原(CEA)　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
癌胚抗原(CEA)	0.32		0.0-3.0	ng/ml

肾功能三项　检验者：梁巧玲　审核者：邬嘉媚　报告时间：2019-09-16

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
尿酸(UA)	451.37	↑	208.3-428.4	umol/L
尿素氮(BUN)	4.20		2.8-7.6	mmol/L
肌酐(Cr)	76.10		64-104	umol/L

实验室检查

尿常规　　检验者：赖树福　　审核者：劳锦辉.　　报告时间：2019-09-12

项目名称	结果	提示	参考范围	单位
颜色(Color)	浅黄色(Light yellow)		黄色(Yellow)	
白细胞(尿常规)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	Leu/uL
亚硝酸盐(NIT)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	
浊度(Turbidity)	清澈(Clear)		清澈(Clear)	
酮体(KET)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	mmol/L
隐血(ERY)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	mg/L
酸碱度(pH)	6.5		4.5-8.0	
尿葡萄糖(GLU)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	mmol/L
尿蛋白(PRO)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	g/L
比重(SG)	1.014		1.003-1.030	
尿胆原(URO)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	umol/L
胆红素(BIL)	阴性(NEG)		阴性(NEG)	umol/L

功能检查报告

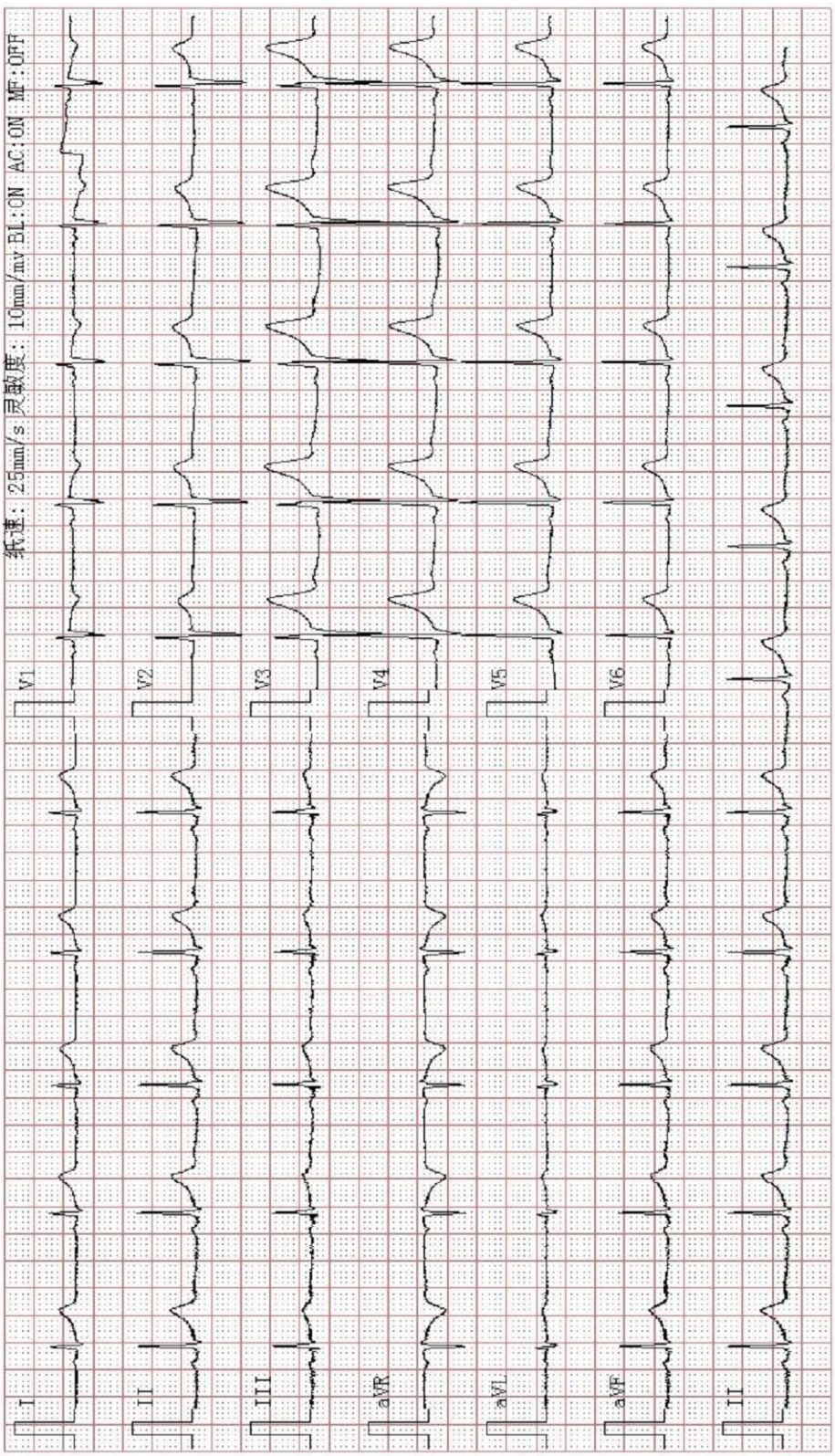
心电图　　检查医生：刘玉兰　　报告日期：2019-09-12

项目名称	检查结果
心电图	窦性心律　正常心电图

香港大学深圳医院香港大学深圳医院心电图报告单

病区:华为体检中心　床号:　就诊号:1909120228　日期:2019-09-12 14:05:20

姓名:李奎声　病人号:AK7114603　P:82　QT/QTc:384/387
性别:男　心　率:61　QRS:84　QRS电轴:+68
年龄:26岁　P-R:126　RV5/SV1:1.55/0.51



诊断提示:
1、窦性心律
2、正常心电图

签名:

报告时间:2019-09-12 14:58:49

本报告仅供临床医生参考，报告医生签字有效

超声检查报告单

检查部位：　甲状腺彩超|肝胆胰脾彩超（空腹）|双肾输尿管膀胱前列腺彩超（憋尿）|

检查所见：

肝脏形态正常，体积不大，肝实质回声稍高，分布尚均匀，肝内未见明显肿物回声。肝内管道结构显示清。CDFI：肝内未见异常血流信号。
胆囊形态大小正常，壁薄光滑，其内未见明显异常回声。肝内胆管未见扩张。
胰腺形态大小正常，回声均匀，其内未见异常回声。
脾脏形态大小正常，回声细小均匀，其内未见异常回声。

双肾形态大小正常，包膜光滑，结构好，未见明确占位性病变，集合系统未见明显扩张，CDFI：双肾内血管分布未见明显异常。
双侧输尿管未见明显扩张。
膀胱充盈良好，壁光滑，内未探及明显异常回声。
前列腺大小形态正常，实质回声欠均匀，未见明显占位性声像，CDFI：未见异常血流信号。

甲状腺形态大小正常，表面光滑，包膜完整，内部回声细小均匀，双侧叶内均可见1-2个无回声暗区，较大直径约3mm。CDFI：腺体内未见异常血流信号。
双侧颈血管鞘旁未见异常肿大淋巴结回声。

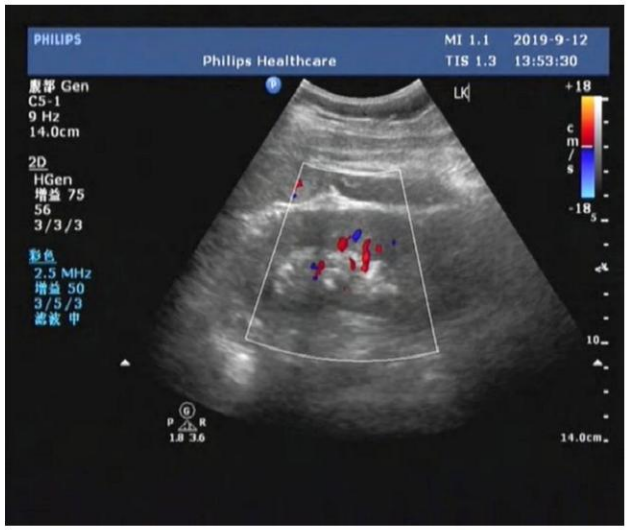
检查提示：

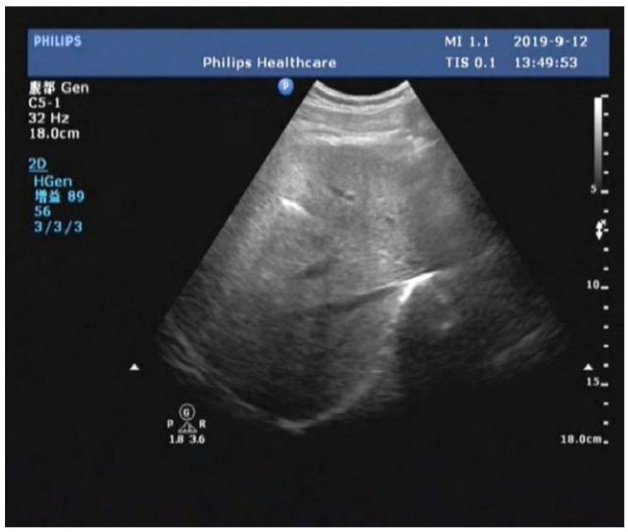
轻度脂肪肝。
甲状腺小囊肿。

检查日期：　2019-9-12　　检查医生：　郑海平

超声检查报告单

检查部位：　甲状腺彩超|肝胆胰脾彩超（空腹）|双肾输尿管膀胱前列腺彩超（憋尿）||





检查日期：　2019-9-12　　检查医生：　郑海平

数字化X线检查诊断报告单

检查部位：　**DR 胸部 正位片|DR 腰椎 正侧位|**

检查所见：

胸廓对称，气管居中。双侧肺野清晰，肺纹理走行规则，未见实质性病变。纵隔不宽，肺门不大。心影大小、形态正常。双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

腰椎序列齐，生理曲度存在；各腰椎骨质完整，边缘光滑清晰，未见骨质增生或破坏；各腰椎椎间隙未见变窄，附件清晰。

诊断意见：

1.两肺及心、膈未见异常。

2.腰椎未见明显异常征象。

报告医生：罗振东　　报告日期：2019-09-15